ONEMA-POP-012 — Versão institucional 1.0

Status: Aprovado pelo RT · Vigência: 09/11/2026 · Responsável técnico: Enf. Marcos Roberto Alves, COREN-SP 983558

Página 1

ONEMA-POP-012 — Uso Seguro de Insulina no Domicílio e Triagem

de Hipo/Hiperglicemia

1. Identificação institucional, código, título, versão e RT

ONEMA SAÚDE | ONEMA-POP-012 | Uso Seguro de Insulina no Domicílio e Triagem de Hipo/Hiperglicemia | Versão

2. Objetivo e abrangência

Padronizar a checagem de segurança da insulina prescrita e a identificação/abordagem inicial de hipo e hiperglicemia em

domicílio.

3. Competência profissional, indicações e contraindicações

Enfermeiro habilitado, com treinamento no dispositivo/condição e atuação nos limites de sua competência; prescrições e

decisões terapêuticas de outros profissionais devem ser respeitadas. Casos graves: SAMU 192. Indicações e limites:

Paciente em uso de insulina com prescrição válida e necessidade de avaliação, educação ou administração prevista no

serviço. Não inclui iniciar, titular ou suspender insulina sem prescrição/plano individualizado.

4. Materiais e equipamentos específicos e fornecimento

Paciente/responsável: insulina prescrita e dentro da validade, caneta/seringa e agulhas compatíveis,

glicosímetro/tiras/lancetas ou CGM validado, carboidrato de ação rápida e glucagon se prescrito. Enfermeiro: EPI, coletor

de perfurocortantes, material para aferições e registro; conferir cadeia de armazenamento.

5. Avaliação clínica e preparação

Verificar tipo de diabetes, esquema prescrito, dose, horário, via, dispositivo, refeição prevista, última aplicação, glicemias

recentes, sintomas, doença intercorrente, capacidade de deglutir e disponibilidade de plano para hipoglicemia.

6. Execução técnica numerada

1. Confirmar paciente e prescrição atual: tipo de insulina, concentração, dose, horário, via, validade e dispositivo; aplicar

barreiras de segurança para medicamentos de alta vigilância.

2. Higienizar mãos; verificar glicemia capilar/CGM conforme indicação e avaliar sintomas; confirmar resultados

discrepantes de sensor com método capilar conforme instruções do fabricante.

3. Antes de administrar, identificar hipoglicemia ou situação que exija decisão clínica; não aplicar dose automaticamente

diante de quadro incompatível com o plano prescrito.

4. Se glicemia abaixo de 70 mg/dL e pessoa consciente, capaz de engolir e sem contraindicação oral, oferecer cerca de

15 g de glicose/carboidrato de ação rápida; reavaliar em 15 minutos e repetir conforme necessidade.

5. Se rebaixamento de consciência, convulsão ou incapacidade de engolir: não administrar nada por via oral; acionar

SAMU 192 e seguir plano individual de glucagon, se prescrito e equipe treinada.

6. Para administração autorizada: conferir identidade, insulina, concentração, dose, via, horário e registro; preparar o

dispositivo conforme instruções do fabricante e realizar dupla checagem quando prevista.

7. Inspecionar locais de aplicação e alternar pontos dentro de regiões apropriadas; evitar áreas de lipohipertrofia,

inflamação ou lesão; realizar aplicação subcutânea conforme dispositivo e treinamento.

8. Descartar agulha imediatamente em coletor rígido; registrar dose, local, horário, glicemia, alimentação, tolerância e

intercorrências.

9. Se hiperglicemia com vômitos, respiração anormal, dor abdominal, desidratação, cetonas elevadas ou alteração

mental, suspeitar de crise metabólica e encaminhar urgentemente; não improvisar correções sem plano prescrito.

7. Interrupção, intercorrências e encaminhamento

Hipoglicemia grave, persistente ou recorrente, alteração neurológica, incapacidade de deglutir, suspeita de cetoacidose/estado hiperosmolar, vômitos e desidratação: atendimento urgente. Rever esquema com prescritor após

episódio clinicamente significativo.

8. Cuidados posteriores e orientações

Ensinar reconhecimento de sintomas, checagem de glicose, armazenamento, técnica do dispositivo, descarte e plano escrito de dias de doença; confirmar entendimento por demonstração.

9. Registros na Carteira Digital ONEMA

Prescrição conferida; tipo, concentração, dose, via, local e horário; glicemias e método; sintomas, alimentos/carboidrato/glucagon quando aplicáveis; resposta após 15 min, educação, eventos e encaminhamentos.

10. Referências técnicas específicas

American Diabetes Association — Standards of Care in Diabetes 2026, Section 6: https://doi.org/10.2337/dc26-s006

American Diabetes Association — Standards of Care in Diabetes 2026, Section 16 (contexto hospitalar): https://doi.org/10.2337/dc26-s016